

DATOS CLÍNICOS



Corrientes, 29 de diciembre de 2025

Budzovsky José Omar 2025

DNI N° 24.257.993

Paciente de 50 años ex tabaquista, portador de Hipertensión arterial con cardiopatía hipertensiva en tratamiento con Valsartan/amlodipina/hidroclorotiazida 160/5/12.5mg ½ comprimido/24hs + Nebivolol 5mg ½ compr cada 24hs. Concorre a evaluación cardiovascular por presentar disnea CF II.

Peso: 122 Kg.

Talla: 184 cm.

IMC: 36 Kg/m²

OBEIDAD -

- Perímetro abdominal: 125 cm

- Perímetro de cadera: 116 cm

N: 94 cm

Acto Riesgo, >102 cm

Presión arterial brazo
derecho

129/76 mmHg

Presión arterial brazo
izquierdo

151/84 mmHg

Presión arterial pierna
derecha

174/89 mmHg

Presión arterial pierna
izquierda

169/78 mmHg

- Tensión arterial en decúbito: 125/73 mm Hg
- TA en bipedestación: 130/82 mm Hg
- Frecuencia Cardiaca: 68 lpm

Datos de contacto:

Correo electrónico: hospitaldia@funcacorr.org.ar - Teléfono: +54-379-4410000 Interno 258

El paciente presenta Obesidad, Hipertensión arterial, Dislipidemia mixta con cardiopatía hipertensiva y ateromatosis carotídea.

Se sugiere:

✚ Iniciar cambios en estilo de alimentación, con el objetivo de descender un 10% del peso actual aproximadamente, a razón de 1 a 1,5 kg por mes. Interconsulta con **nutricionista**.

✚ Actividad física **regular**, programada. Idealmente 300 minutos semanales de **actividad aeróbica** de intensidad **moderada** (caminata, ~~trote liviano~~, bicicleta, natación, etc) y **fuerza muscular**, distribuidos en 3 a 5 veces por semana.

FINAC - 300 min / semana.
NIJAL - 25 min / día

✚ Interconsulta con neumólogo.

✚ Realizar presurometria.

✚ Realizar controles periódicos de presión arterial en domicilio. (2 veces/semana, antes de la toma de la medicación y todos los días la semana previa antes de la consulta con su médico).

✚ Repetir perfil lipídico en 2 meses.

✚ Control con médico de cabecera (solicitar turno).

Medicación:

✚ Valsartan/amlodipina/hidroclorotiazida 160/5/12.5mg $\frac{1}{2}$ comp. cada 24hs VO

✚ Nebivolol 5mg $\frac{1}{2}$ comp. cada 24hs VO

✚ Rosuvastatina 20 mg 1 comp. cada 24hs VO (cena).

Datos de contacto:

Correo electrónico: hospitaldia@funcacorr.org.ar - Teléfono: +54-379-4410000 Interno 258

Dra. MA. LAURA REYES PRIETO
M.P. 5625
Médico Cardiólogo
Instituto de Cardiología de Ctes.

ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR SCORE

HOMBRES

Paso 1

Edad		
Años	LDL pts	Col pts
30-34 años	-1	[-1]
35-39 años	0	[0]
40-44 años	1	[1]
45-49 años	2	[2]
50-54 años	3	[3]
55-59 años	4	[4]
60-64 años	5	[5]
65-69 años	6	[6]
70-74 años	7	[7]

Paso 2

LDL-C	
md/dl	LDL pts
< 100	-3
100-130	0
130-159	0
160-190	1
>190	2

Colesterol total	
md/dl	Coolest pts
< 160	-3
160-199	0
200-239	1
240-279	2
>280	3

Paso 7

Suma de puntaje	
Edad	3
LDL o Coolest	1
HDL-C	2
Presión arterial	0
Diabetes	0
Fuma	0
Puntaje total	6

Paso 3

HDL-C		
md/dl	LDL pts	Coolest pts
< 35	2	[2]
35-44	1	[1]
45-49	0	[0]
50-59	0	[0]
>60	-1	[-2]

Paso 4

Presión arterial				
Sistólica	Diastólica			
	<80	80-84	85-89	90-99 >100
< 120	0 pts	0 pts		
120-129			1 pto	
130-139				2 pts
140-159				3 pts
>160				

Paso 5

Diabetes		
	LDL pts	Coolest pts
No	0	[0]
Si	2	[2]

Paso 6

Fuma		
	LDL pts	Coolest pts
No	0	[0]
Si	2	[2]

Color	Riesgo
	Muy bajo
	Bajo
	Moderado
	Alto
	Muy alto

Paso 8

Riesgo CV a 10 años			
LDL pts	Riesgo CV a 10 a	Coolest pts	Riesgo C a 10 a
<-2	1%		
-2	2%		
-1	2%	[-1]	[2%]
0	3%	[0]	[3%]
1	4%	[1]	[3%]
2	4%	[2]	[4%]
3	6%	[3]	[5%]
4	7%	[4]	[7%]
5	9%	[5]	[8%]
6	11%	[6]	[10%]
7	14%	[7]	[13%]
8	18%	[8]	[16%]
9	22%	[9]	[20%]
10	27%	[10]	[25%]
11	33%	[11]	[31%]
12	40%	[12]	[37%]
13	47%	[13]	[45%]
>14	>56%	[>14]	[53%]

Este score de riesgo se basa en estudios poblacionales. Indica riesgo de presentar un evento cardiovascular (infarto, accidente cerebrovascular o muerte súbita) en los próximos 10 años

En el método tradicional Ud. Tiene un 11% de probabilidades de desarrollar un evento cardiovascular en los próximos 10 años (RIESGO BAJO). De todas maneras el haber encontrado nuevos marcadores de riesgo (daño subclínico de órgano) lo reestratifican en un paciente de **ALTO RIESGO**

Riesgo muy alto

Datos de contacto:

Correo electrónico: hospitaldia@funcacorr.org.ar - Teléfono: +54-379-4410000 Interno 258

RESULTADOS



Laboratorio

 **Colesterol Total 214 mg/dL, HDL 30 mg/dL, Triglicéridos 218 mg/dL, LDL 145 mg/dL, Glucemia 98 mg/dL, HA1c 5.60 %, creatinina 1.00 mg/dL, clearance de creatinina 92 ml/min/m2 (CKD-EPI), ac úrico 6.0 mg/dL, microalbuminuria espontánea 3 mgAlb/gCr.**

Electrocardiograma

 Ritmo sinusal.

Ergometría

 Submaximo negativo. **Respuesta hipertensiva mixta.** CFE: I (11 Mets) Muy buena capacidad funcional. DP: 30015. Frecuencia Máxima Alcanzada: 145 lpm (85%).

Ecografía Doppler de vasos de cuello

 **Ateromatosis leve en bulbo carotideo derecho.**

Ecografía Doppler color cardiaco

 **Insuficiencia mitral leve. Dilatación de la aurícula izquierda. Hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo.** Fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada. **Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo grado ii (pseudonormal).**

Datos de contacto:

Correo electrónico: hospitaldia@funcacorr.org.ar - Teléfono: +54-379-4410000 Interno 258